EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	: HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	: 81762
SERVICIO	: UTI HSC		
FECHA	: 2024-04-02 10:55:00		

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ISABEL DEL CARMEN SOTO AGURTO			**RUN**	: 6.806.144-K
F.Nac	: 13-06-1950	**Edad**	: 73 AÑOS, 9 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: LOS GUINDOS			**Comuna**	: NIQUEN
Previsión	: SIN INFORMACION	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-03-22	**Fecha Egreso**	: 2024-04-02 10:55:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J81-EDEMA PULMONAR

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. EPA hipertensivo resuelto
2. Emergencia hipertensiva resuelta.
3. ICC descompensada con FE 50% (2022)
4. Antecedentes crónicos: ERC etapa 3a, ACV secuelado, FA en TACO, HTA etapa 3

Procedimientos UTI: instalación de línea arterial, Sonda Foley, VMNI (CPAP) 24 hrs

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J81-EDEMA PULMONAR (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J81-EDEMA PULMONAR (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I10.XS-HIPERTENSION ARTERIAL SEVERA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. I50.0-INSUFICIENCIA CARD?ACA CONGESTIVA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. I48.1-FIBRILACION AURICULAR PERSISTENTE (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. N18.3-ENFERMEDAD RENAL CRONICA,ESTADIO 3 (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes de HTA, IC cFE 50%, FA aparentemente sin TACO, secuela motora BC izq ACV. Consulta en SU HSC la noche del 21/03 por cuadro de disnea, cefalea y síntomas inespecíficos que inician el mismo día según lo referido por la paciente. Hospitalizada en diciembre 2022 por cuadro similar. Destaca a su ingreso HTA 180/100 mmHg FC 82 lpm sat 93% amb, evoluciona con mayor compromiso hipertensivo (hasta 250/140 mmHg) y desaturación, requiriendo apoyo con FiO2 4 lt por naricera, se inicia BIC NTG (1:30 am), furosemida 80 mg ev, morfina 3mg . Dentro de los exámenes destaca aumento parámetros inflamatorios, ECG en RS con complejo QRS normal, AngioTC torax con signos de congestión pulmonar, derrame pleural bilateral, sin signos de TEP. Se solicita evaluación por Residente de UTI a las 5:00 hrs am, tras lo cual se decide su ingreso a la Unidad para continuar manejo.
En UTI evoluciona muy hipertensa, con requerimiento de BIC nitroglicerina con escasa respuesta inicial, se optimiza tratamiento antihipertensivo oral, posteriormente con BIC urapidil, con persistencia de hipertensión severa. ACtualmente sin BIC urapidil, HTA sistólica 150-170 mmHg, siempre asintomática. Se inició terapia depletiva full en contexto de EPA y manejo con VMNI por

24 hrs con buena respuesta, logrando BH negativos y luego neutros. Con requerimiento FiO2 con naricera hasta 2 lt. Se toma imagen de torax control por dificultad en destete de FiO2 , con infiltrado basal asociado a parámetros inflamatorios aumentados por lo que se inicia atb empírico con ceftriaxona x 5 dias con buena respuesta clínica y laboratorio.
En cuanto a su falla renal, ingresa con LRA, la cual logra mejorar algo pero quedando con función sobre basal, en etapa 4. Sin urgencia dialítica. Se realiza IC por GES para evaluación ambulatorio por nefrologia en HHMCH.
En cuanto a su FA ya registrada en hospitalización previa, se inicia terapia anticoagulación con acenocumarol, por fx renal, aún en etapa de ajuste dosis para INR 2-3. No fue posible realizar Ecocardiograma durante hospitalización por encontrarse muy hipertensa, difiriéndose para ambulatorio.
Se solicita HODOM para ajuste TACO y KNT motora en contexto de hospitalización prolongada.

PLAN DE MANEJO:

HODOM para ajuste Acenocumarol
control ambulatorio nefrología y cardiología

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido
2. Regimen liviano hiposódico, restricción hídrica 800 cc/día en total
3. Acenocumarol d1/2 comprimido hoy, ajuste dosis mañana según INR (se propone: 1/4 de Lu a Sa y 1/2 Do)
4. Furosemida 40 mg/día vo
5. Amlodipino 10 mg c/12hrs vo
6. Hidralazina 100 mg c/6hrs vo
7. Carvedilol 6,25 mg 1/2 comprimido c/12 hrs vo
8. Metildopa 250 mg c/8hrs vo
9. Isosorbide 10 mg c/6hrs vo
10. Doxazocina 4 mg c/12hrs vo (lo compra paciente)
11. Omeprazol 20 mg 1 capsula antes desayuno vo
12. Atorvastatina 40 mg/noche vo
13. HODOM para ajuste de TACO y KNT motora
14. Se realiza IC nefrología HHMCH ambulatorio (02/04/24)
15. Control en Poli de cardiología en 1 mes (HTA severa de difícil manejo + Insuficiencia cardiaca)
16. Al alta ingreso Poli TACO

EXÁMENES Y RESULTADOS

02/04/24: crea 2.5 PCR 6.9 BUN 52 Hb 10 Hto 29.5 Plt 241 mil INR 1.71 TTPK 30
01/04/24: Crea 2.5, ELP 134/3.9/103
30/03/24: Crea 2, PCR 10, ELP 141/3.7/107, leuco 6.900, Hcto 30, Hb 10.1
29/03/24: Alb 3.3, Crea 2.1, Ca 8.6, PCR 12.7, Nu 79, ELP 143/3.5/111, INR 2.68, TTPA 60, leuco 6.500, Hcto 27.7, Hb 9.3, Plaquetas 242
28/03/24: crea 2.0, ELP 144/3.8/112
27/03/24: crea 2,4 ELP 144/3,6/113 GB 6400 Hb 9.5 Plt 226 PCR 24,6
25/03/24: glic 118 crea 2.5 VFG 18,8 GB 8500 Hb 9,4 Plt 224 mil VHS 13 ELP 146/3.1/109 GSA pH 7,44 pCO2 39,3 pO2 75,2 Bic 26,8

Control en: 30 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Ana Sepúlveda Venegas
MEDICO TRATANTE
13383078-2

JEFE SERVICIO